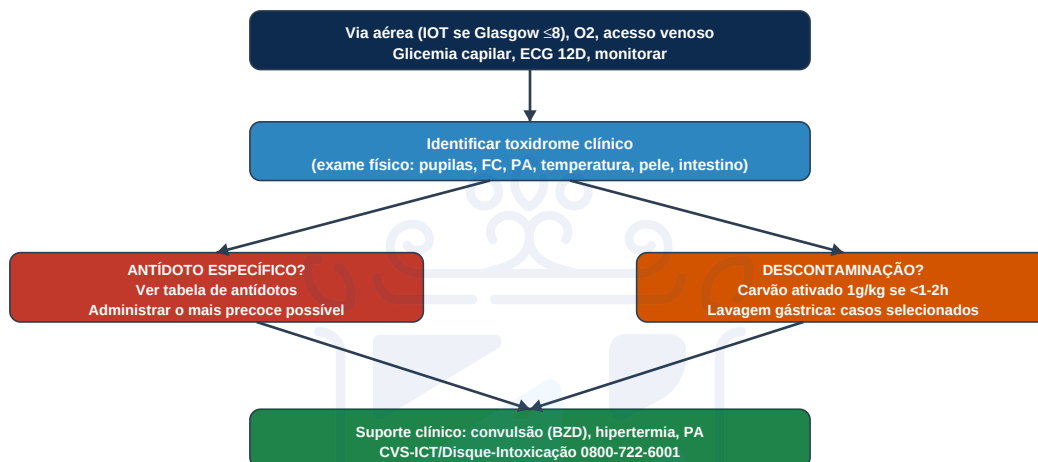


INTOXICAÇÃO — TOXIDROME E ANTÍDOTO

ABORDAGEM INICIAL — INTOXICAÇÃO

INTOXICAÇÃO — ABC PRIMEIRO



TOXIDROMES — RECONHECER PELO EXAME

Toxidrome	Pupilas	FC/PA/Temp	Clínica	Causa
Simpaticomimético	Midríase	↑FC/↑PA/↑T	Agitação, tremor, convulsão, sudorese	Cocaína, anfetamina, efedrina
Colinérgico (SLUDGE)	Miose	↓FC/↓PA/normal	Sialorreia, lacrimejamento, broncoespasmo, diarreia, vômitos, bradicardia	Organofosforados, carbamates
Anticolinérgico	Midríase	↑FC/↑PA/↑T	Pele seca quente, bexiga retida, agitação, delírio, rubor	Atropina, ATC, anti-H1, cogumelos
Opioide	Miose intensa	↓FC/↓PA/↓T	Depressão respiratória, coma, pele fria, resposta à naloxona	Morfina, heroína, codeína, metadona
Sedativo-hipnótico	Midríase/normal	↓FC/↓PA/↓T	Sedação, ataxia, coma, sem miose, resposta parcial ao flumazenil (BZD)	BZD, barbitúricos, GHB, álcool

SM24
Suporte ao Plantão Médico

ANTÍDOTOS PRINCIPAIS — REFERÊNCIA RÁPIDA

Tóxico	Antídoto	Dose
Opioide (morfina, heroína)	Naloxona	0,4-2 mg IV/IM/IN; repetir 2-3 min; infusão se metadona
Benzodiazepínico	Flumazenil	0,2 mg IV, repetir 0,1 mg até 1 mg (cuidado: convulsão)
Organofosforado	Atropina (sulfato)	2-4 mg IV a cada 5-10 min até secar secreções
Paracetamol	N-acetilcisteína (NAC)	150 mg/kg IV em 60 min, depois manutenção por 21h
Metanol/etilenoglicol	Fomepizol (ou etanol IV)	15 mg/kg IV; diálise se grave
Tricíclico (ATC)	Bicarbonato de sódio	1-2 mEq/kg IV se QRS >100ms ou arritmia
Intoxicação digitálica	Anticorpos anti-digoxina (Fab)	Dose = carga estimada / 0,5 (mg)
Warfarina / Anti-vit K	Vitamina K + CCP/PFC	Vitamina K 10 mg IV + CCP 25-50 UI/kg se sangramento grave
Metabissulfito, CN (CN-)	Hidroxibalamina (Cyanokit)	5g IV em 15 min; indicado em intoxicação por fumaça
Ferro	Deferoxamina	15 mg/kg/h IV; se ferritina >500 + sintomas

DESCONTAMINAÇÃO — INDICAÇÕES E LIMITES

CARVÃO ATIVADO E LAVAGEM GÁSTRICA

- Carvão ativado 1g/kg (máx 50-100g) VO/SNG: eficaz se ingestão <1-2h, via aérea protegida, sem íleo
- NÃO para: hidrcarbonetos, metais pesados, álcoois, cáusticos, lítio, ferro (não adsorve)
- Lavagem gástrica: raramente indicada (risco de aspiração); casos selecionados <1h, tóxico perigoso
- Catárticos: NÃO usar (sem benefício, risco de distúrbio eletrolítico)
- Irrigação intestinal (polietilenoglicol): pacotes lentos de liberação, drogas de corpo (body packer)
- Diurese forçada: ácidos fracos (salicilatos) e bases fracas (anfetaminas) — alcalinizar/acidificar urina

INTOXICAÇÃO POR ORGANOFOSFORADO — URGÊNCIA

SLUDGE + Nicotínico

- S — Sialorreia (salivação excessiva)
- L — Lacrimejamento
- U — Urinary (incontinência urinária)
- D — Defecação (diarreia)
- G — GI (cólicas abdominais)
- E — Emesis (vômitos)
- + miose + broncospasmo + bradicardia

Tratamento Organofosforado

- Atropina: 2-4 mg IV a cada 5-10 min até secar secreções (não pela FC)
- Pode precisar de centenas de miligramas
- Pralidoxima (2-PAM): 1-2 g IV em 15-30 min (reativa AChE — dar cedo)
- Benzodiazepínico: convulsões
- Remover roupas, lavar pele (contaminação dérmico-inalatória)
- UTI; risco de paralisia respiratória tardia (síndrome intermediária)

PARACETAMOL — MAIOR CAUSA DE FALÊNCIA HEPÁTICA

PROTOCOLO NAC

- ☐ Suspeitar sempre: tentativa de suicídio em jovem, dose >150 mg/kg ou >7,5g em adulto
- ☐ Nível sérico 4h após ingestão → nomograma de Rumack-Matthew
- ☐ N-acetilcisteína (NAC): iniciar se <8h da ingestão ou nível acima da linha de tratamento
- ☐ Protocolo 21h IV: 150 mg/kg em 60 min → 50 mg/kg em 4h → 100 mg/kg em 16h
- ☐ Monitorar: transaminases, INR, creatinina, glicemia
- ☐ Insuficiência hepática fulminante: critérios de King's College → transplante



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Qual toxidrome cursa com miose, bradicardia, broncoespasmo, sialorreia e incontinência urinária?

- A) Simpaticomimético (cocaína)
- B) Opioide (morfina)
- C) Anticolinérgico (atropina)
- D) Colinérgico (organofosforado)
- E) Sedativo-hipnótico (benzodiazepínico)

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com intoxicação por organofosforado (pesticida). A dose de atropina deve ser titulada pelo seguinte parâmetro:

- A) Frequência cardíaca >100 bpm
- B) Ressecamento de secreções brônquicas e redução do broncoespasmo
- C) Normalização da pressão arterial
- D) Desaparecimento da miose
- E) Temperatura corporal $\leq 37,5^{\circ}\text{C}$

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é o antídoto para intoxicação grave por paracetamol?

- A) Flumazenil
- B) Naloxona
- C) N-acetilcisteína (NAC)
- D) Atropina
- E) Fomepizol

QUESTÃO 4

SES-DF / Adaptada

Em qual situação o carvão ativado é CONTRAINDICADO para descontaminação gastrointestinal?

- A) Ingestão de paracetamol há 45 minutos
- B) Ingestão de benzodiazepínico há 30 minutos
- C) Ingestão de produtos cáusticos (ácidos/bases fortes)
- D) Ingestão de carbamazepina há 1 hora
- E) Ingestão de digoxina há 1 hora

QUESTÃO 5

UFPR / Adaptada

Paciente com overdose de tricíclico (amitriptilina) apresenta QRS largo >120 ms e hipotensão. Qual é a medida farmacológica de PRIMEIRA LINHA?

- A) Flumazenil 0,2 mg IV
- B) Naloxona 0,4 mg IV
- C) Bicarbonato de sódio 1-2 mEq/kg IV
- D) Lidocaína IV antiarrítmica
- E) Amiodarona 300 mg IV

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: D

Toxidrome colinérgico (SLUDGE + muscarínico + nicotínico): miose, bradicardia, broncoespasmo, sialorreia, incontinência. Causa: organofosforados, carbamatos. Antídoto: atropina.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Atropina nos organofosforados é titulada pelo ressecamento das secreções brônquicas e alívio do broncoespasmo — NÃO pela FC. A taquicardia sinusal pura não é parâmetro de tratamento. Pode-se usar centenas de miligramas.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

N-acetilcisteína (NAC) é o antídoto do paracetamol, repondo glutatona e prevenindo a formação do metabólito hepatotóxico (NAPQI). Iniciar se ingestão <8h OU nível sérico acima da linha de tratamento no nomograma.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Carvão ativado é contraindicado em: cáusticos (aumenta risco de perfuração + sem eficácia), hidrocarbonetos, metais pesados, lítio, ferro, álcoois. Não adsorve esses compostos e pode piorar o manejo endoscópico.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Bicarbonato de sódio (1-2 mEq/kg IV) é o tratamento de 1ª linha na cardiotoxicidade por tricíclico: alcaliniza o sangue e reverte o bloqueio dos canais de sódio. Alvo: pH sérico 7,50-7,55; reduz QRS e melhora hipotensão.

SM24
Suporte ao Plantão Médico